

Powrót *po nawrocie*

Nawrót nie oznacza końca pracy. Oznacza, że trzeba zrozumieć, co się stało, i wrócić silniej. Karta przedstawia protokół konstruktywnego powrotu.

CZAS: 1–2 tyg. pracy Po pełnym nawrocie

ŹRÓDŁO: Marlatt & Donovan (2005); Witkiewicz & Marlatt (2007)

JAK UŻYWAĆ

Nawrót (pełny powrót do wzorca PPU) jest **częstym** doświadczeniem w terapii — 50% pacjentów ma go w pierwszych 12 mies. (Dennis 2014). To *nie jest porażka* — to jest *część procesu*. Karta przedstawia **konstruktywny protokół** powrotu: 1) *natychmiastowe* reakcje (24 h), 2) *analiza* w 1 tygodniu, 3) *plan* wzmocnienia, 4) odbudowa narracji siebie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Marlatt & Donovan (2005) podkreślają: **nawrót zawiera kluczowe informacje**. Pacjent, który traktuje nawrót jako klęskę i się poddaje — traci szansę. Pacjent, który analizuje nawrót jako *okazję do nauki*, wraca *silniejszy*. Witkiewicz & Marlatt (2007, „mindful relapse prevention”) wykazali: pacjenci, którzy aktywnie analizują nawrót, mają w 2 lata **50% mniej** kolejnych nawrotów niż ci, którzy go „zapomną”. Klucz: **nawrót nie jest powrotem do punktu zero**. Wszystko, co nauczyłeś się przez X miesięcy, nadal w tobie jest. Lapse to lapse, nie unicestwienie pracy. Pacjent z 6 miesiącami pracy + nawrót — ma znacznie inny start niż pacjent z 0 miesiącami pracy. To kluczowa wiedza, którą wstyd potrafi zatrzeć.

01 = Pierwsze 24–48 godzin po nawrocie

CO ROBIĆ

- **Zatrzymać.** Fizycznie wyjść z miejsca, zmienić otoczenie.
- **Skontaktować.** Z terapeutą / siecią wsparcia. Bez ukrywania.
- **Plan 48 h.** Co robię następne 2 doby — minutowo. Bez wolnego czasu.
- **Autosympatia.** „Jestem człowiekiem. To było ciężkie. Wracam.”
- **Sen, jedzenie.** Podstawy. Reszta później.

CZEGO NIE ROBIĆ

- **Nie biczować.** Wstyd nie pomaga, napędza spiralę.
- **Nie izolować.** Ukrywanie nawrotu = jego pogłębienie.
- **Nie podejmować dużych decyzji.** „Rozwód”, „rzucam terapię” — nie teraz.
- **Nie obiecywać „nigdy więcej”.** Niewykonalne. Lepiej: „wracam do planu”.
- **Nie ekspiacja.** Nadmierne ćwiczenia, post — kompensacja szkodliwa.

02 Tydzień analizy — co się stało

Sytuacja wysokiego ryzyka. Co dokładnie się działo na 24–72 h przed pierwszym epizodem? Konflikt, stres, samotność?

Pozornie nieistotne decyzje. Jakie wybory poprzedziły? „Sprawdzę Instagram”, „zostanę dłużej w pracy”?

Sygnaly ostrzegawcze. Czy były wcześniejsze sygnaly (gorszy sen, izolacja, fantazje)? Czy je zauważyłem?

Brakujące narzędzia. Czego mi zabrakło? Sieci wsparcia, regulacji emocji, blokerów, autosympatii?

AVE. Po pierwszym epizodzie — czy wpadłem w „i tak stracone, mogę dalej”? Co bym mógł powiedzieć sobie inaczej?

Wnioski. Co konkretnie wzmocnię w planie? Jeden konkretny krok, nie 10 ogólnikowych.

03

**Twoja analiza po nawrocie****SYTUACJA WYSOKIEGO RYZYKA**

— co poprzedzało

KONKRETNE WZMOCNIENIE PLANU

— 1 konkretna zmiana

SYGNAŁY, KTÓRE ZIGNOROWAŁEM/-AM

— co było wcześniej

CO DALEJ Z RELACJĄ

— kiedy i jak powiedzieć partnerce

04

● Odbudowa narracji — kluczowe stwierdzenia

„**Nawrót nie unicestwił mojej pracy.**” Wszystko, co nauczyłem się — nadal we mnie jest. Wracam z 6 mies. doświadczenia + 1 nawrót = 6 mies. doświadczenia + nauka.

„**Nawrót jest częścią procesu.**” 50% pacjentów w pierwszych 12 mies. ma nawrót. Nie definiuje mnie, definiuje statystykę.

„**Wracam silniejszy.**” Wiem teraz więcej o swoich wzorcach. Plan wzmacniam o konkretną wiedzę.

„**Praca trwa lata, nie dni.**” Stabilność po 5 latach jest znacznie wyższa niż po 1. Cierpliwość.

Klucz: Witkiewicz & Marlatt (2007) podkreślają, że **najsilniejszy predyktor** długoterminowej zmiany *nie* jest brakiem nawrotów — jest **jakością powrotu po nawrocie**. Pacjenci, którzy umieją wracać konstruktywnie, wygrywają w długim okresie. Pacjenci, którzy poddają się po pierwszym nawrocie, tracą szansę. Praktyczna rada: **przygotuj protokół powrotu zanim go potrzebujesz**. Numery do osób z sieci wsparcia, plan 48 h, autosympatyczne stwierdzenia. Gdy nawrót nastąpi — sięgasz po gotowy plan, nie wymyślasz w pobudzeniu. To różnica między pacjentem, który traci 6 mies. po nawrocie, a pacjentem, który traci 1 dzień.